



NOMBRE DEL ESTUDIANTE 4to SEMESTRE 2025A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD:	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: PIELOLITOTOMIA

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

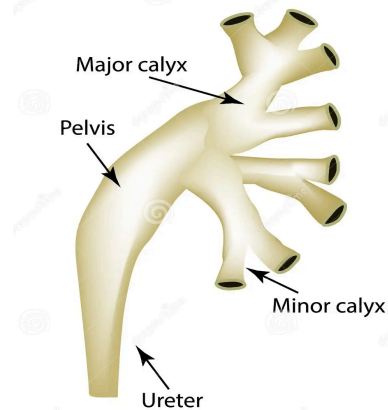
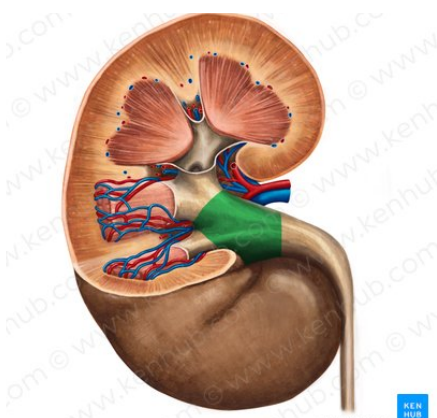
• ETAPA DE PLANEACIÓN:

1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción)

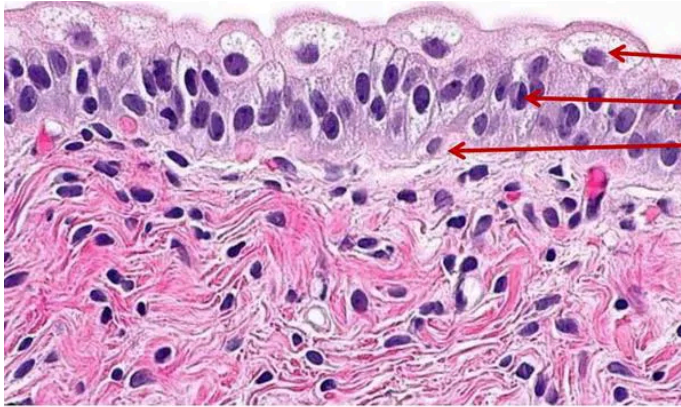
Resectar la porción estrecha de la unión pieloureteral para realizar una anastomosis que permita el adecuado paso de la orina desde el riñón hacia la vejiga por medio del uréter. En este procedimiento se expone el riñón más exactamente la unión pieloureteral a través de la fascia de gerota después se realiza la escisión del segmento estenosado y posteriormente se realiza colocación de un catéter doble J para finalizar con una anastomosis término terminal entre la pelvis renal y el uréter espatulado.

1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción).

ANATOMÍA



La pelvis renal es una estructura anatómica del sistema urinario situada en el hilio del riñón, tiene forma de un embudo, con una amplia base que recibe la orina de los cálices mayores y una punta estrecha que se continúa con el uréter. Está compuesta por: cáliz mayor, cáliz menor y uréter.



EPITELIO:

Capa superficial

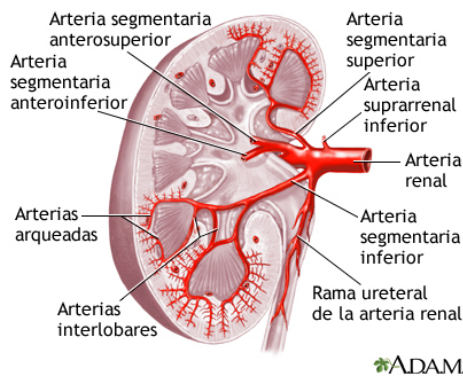
Capa celular intermedia

Capa celular basal



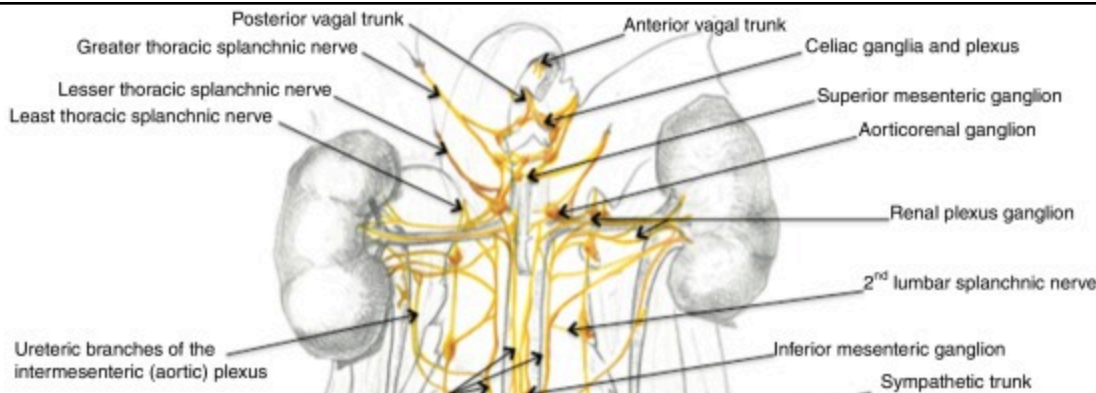
Estructuralmente está constituida por una mucosa, una túnica muscular lisa, dispuesta en una capa interna circular que ayuda en el movimiento de la orina hacia el uréter por medio de contracciones peristálticas y una capa externa longitudinal, y una adventicia. La pelvis renal está revestida por un epitelio de transición, llamado **UROTELIO**, que es flexible y resistente a la orina.

IRRIGACIÓN



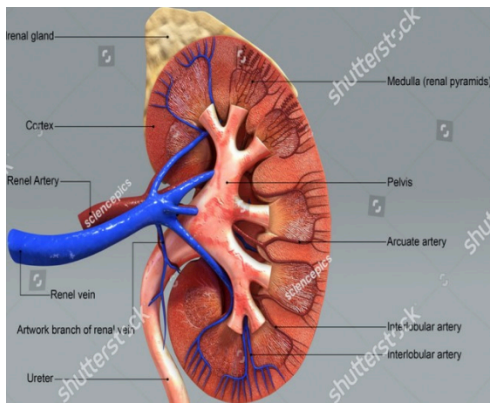
Se encuentra irrigado anteriormente por la Arteria Renal de manera posterior con la rama posterior que medialmente se prolonga hasta los vasos pre vertebrales, gonadal, iliaca común, vesical y uterina.

INERVACIÓN



Recibe innervación parasimpática de los nervios Esplénicos Pélvicos y del plexo hipogástrico inferior.

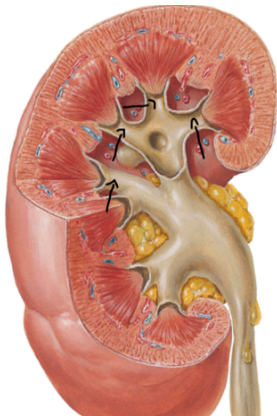
DRENAJE VENOSO



Su drenaje venoso consta de las ramas de la Vena Renal. La sangre de la pelvis renal drena hacia las venas renales, que luego desembocan en la vena cava inferior.

- Los plexos venosos de la pelvis rodean los órganos pélvicos.
- La mayoría de los plexos venosos desembocan en la vena ilíaca interna.
- La vena ilíaca interna recibe afluentes de las venas rectal media, obturatriz, sacra lateral, glútea inferior y glútea superior.

FISIOLOGÍA



Su función principal es actuar como embudo que recoge la orina producida en el riñón y la dirige hacia el uréter, desde donde se transporta a la vejiga para su almacenamiento y posterior eliminación.

- **Recogida y canalización:** La orina producida en las nefronas se recoge en los túbulos colectores y luego se drena hacia los cálices menores. Desde allí, la orina fluye hacia los cálices mayores y finalmente a la pelvis.
- **Peristalsis:** Las contracciones peristálticas del músculo liso en la pared de la pelvis renal ayudan a propulsar la orina hacia el uréter.



- **Prevención del reflujo:** La anatomía de la unión pieloureteral (donde la pelvis renal se conecta con el uréter) ayuda a prevenir el reflujo de orina hacia los riñones, lo cual es esencial para evitar infecciones y daño renal.
- **Adaptabilidad:** El urotelio tiene la capacidad de expandirse y contraerse, permitiendo a la pelvis manejar diferentes volúmenes de orina sin sufrir daño.
- **Protección Inmunológica:** La pelvis renal posee una mucosa que actúa como barrera defensiva contra patógenos y sustancias tóxicas presentes en la orina.

1.3. Lista de chequeo:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FÁRMACOS Y SOLUCIONES
• Canasta General • Canasta Vascular • Canasta de Tórax	• Paquete de ropa general • Sabana accesorio • HB #20-15 • Compresas • Torundas • Apósitos • Gasas • Aseptojeringa • Guantes • Lapicero del electrobisturí • Pala mediana o larga del electro • Caucho de succión • Equipo de macrogoteo • Sonda de Nelaton 10 • Dren de cigarrillo • Dren de Blake 19 • Catéter doble J 6x26 Adultos 4x18 Niños • Vessel Loop • Reservorio 100cc • Jeringa 20 cc	• Piel: Polipropileno 3/0 ACC 3/8. Polidioxanona 4/0 ACC para niños. • Tejido celular subcutáneo: Poliglactin 910 3/0 ACR ½ círculo • Fascia - Músculo: Poliglactin 910 1 o 0 ACR ½ círculo • Pielorrafia: Poliglactin 910 4/0 ACR 1/2 círculo Polidioxanona 4/0 ACR • Fijación del Dren: Seda 2/0 ACC 1/2 círculo Y catéter doble J	• Solución salina



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

PROGRAMA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA

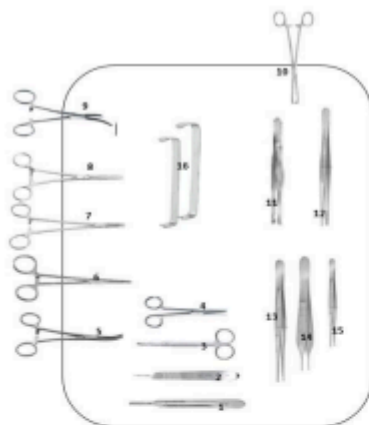
**PLANEAMIENTO QUIRURGICO PRACTICA
FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC**

Versión: 01

--

• **ETAPA DE ORGANIZACIÓN:**

- o Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).

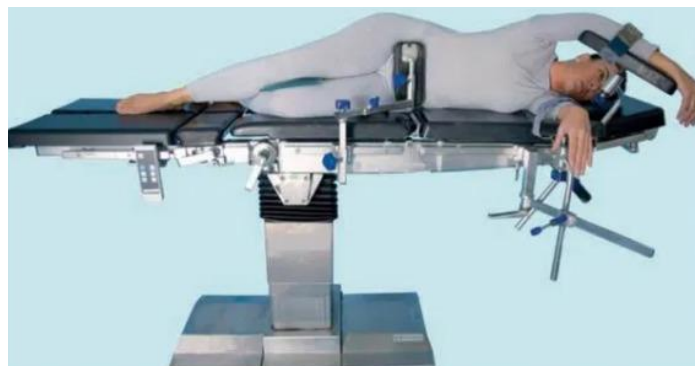


1. Mango de bisturí 4 – HB #20
2. Mango de bisturí 3 – HB #15
3. Tijeras de Metzembaun
4. Tijeras de mayo recta
5. Pinzas Kelly curva
6. Pinzas Kelly Recta
7. Pinza Kelly Adson
8. Pinzas Rochester Curva
9. Pinza Rochester recta
10. Pinza Allix
11. Pinza de disección rusa
12. Pinza de disección sin garra larga
13. Pinza de disección con garra larga
14. Pinza de disección sin garra corta
15. Pinza de disección Adson con garra
16. Separadores de Farabeuf.



1. Canasta General
2. Paquete de ropa y canasta vascular, vesicular y tórax
- 3.1 Separadores Balfour
- 3.2 Valvas maleables
- 3.3 separador de Balfour con su valva
4. Tijera de metzenbaum fina
5. Tijera de mayo larga
6. Pinza de foerster
7. Pinza Randall
8. Sonda Nelaton
9. Sonda de Blake con su reservorio
10. Electrobisturí con pala mediana o larga
11. Guantes
12. Cánula
13. Yankauer
14. Compresas
15. Suturas
16. Porta agujas
17. Catéter doble J
18. Coca
19. Pinza de campo.

2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):



DECÚBITO LATERAL



2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):



- **ETAPA DE EJECUCIÓN:**

a) **Anestesia (escribir el tipo de anestesia):**

- Anestesia General.

b) **Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):**

- Abordaje abierto con incisión de lumbotomía



c) Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico-quirúrgica con el instrumental a usar).

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTAL
Se realiza incisión de lumbotomía, piel, tejido celular subcutáneo	Mango de bisturi 4 hoja # 20
Hemostasia	Kelly Curva y Lapicero del electrobisturí
Se hace visualización de la fascia muscular del músculo oblicuo	Separadores de farabeuf y electro bisturi
Incisión de los músculos oblicuo interno , oblicuo transverso, cuadrado lumbar y psoas.	Electrobisturi
Se llega a la cavidad retroperitoneal y se visualiza el riñón Separadores de Deaver	Separadores de Deaver
<i>Se hace una incisión en la fascia Gerota y se disecciona la grasa peri nefrótica</i>	<i>Tijeras de Metzembraum y pinza de disección larga</i>
Disección del uréter hasta la pelvis renal y se repara con disección roma.	Tijeras de Metzembraum , disección vascular, pinza cístico, pinza kelly recta y curva , pinza rochester recta y vessel loop.
Se separa la pelvis renal	Separador de vena
Se realiza incisión en la pelvis renal	Mango de Bisturí 3 largo HB#15
Se drena la orina acumulada	Canula de yankauer
Reparo de la pelvis renal y se hace la extracción de los cálculos	Pinza cístico, pinza kelly recta , Pinza randall, Vessel loop y coca.
Lavado de la pelvis renal , se comprueba la permeabilidad de esta misma	Sonda nelaton 10 , Jeringa de 20cc Solución Salina
Colocacion de cateter doble J	Pinza vascular , guía del catéter y catéter
Cierre de la pelvis renal	Porta agujas largo, pinza de disección vascular , Poliglactin 910 4/0 ACR ½ círculo.



Retiro del reparo del uréter y revisión de la cavidad Dren por contraventura	Pinza Kelly Adson curva , porta agujas , disección con garra y sutura seda 2/o ACC
Recuento de compresas y lavado de la cavidad	Pinza foerster y solución salina tibia
Cierre por planos y curación.	Porta Agujas mediano, pinzas de disección con garra , separadores de farabeuf y Poliglactin 910 1 aguja ½ circulo ACR y Polipropileno 3/o ACC ¾ círculo.

FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES